UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO
Departamento de Ciências de Computação

Departamento de Ciências de Computação – SCC
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC
Universidade de São Paulo – USP
Disciplina SCC0245 – Processamento Analítico de Dados

Docente Responsável: Profa. Cristina Dutra de Aguiar

Trabalho Prático 1

Data Warehouse para Análise da Cobertura da Atenção Primária a Saúde em São Carlos

Unidades e equipes de saúde, demanda ambulatorial e internações evitáveis

Integrante	**Nº USP**
Ivan Sardon Medina	[Nº USP]
Vinícius Morotti	[Nº USP]
Germano Antonio Zani Jorge	[Nº USP]
Matheus Rodrigues	[Nº USP]

São Carlos, 29 de Outubro de 2026

Índice

1. Descrição do Problema 3
1.1 Tema geral do trabalho 3
1.2 Fontes de dados 3
1.3 Processos de negócio 4
1.4 Dimensões e seus atributos 6
1.5 Povoamento e integração dos dados 11
1.6 Particularidades do problema 12
2. Esquemas 14
2.1 Esquema estrela 1 – Oferta de equipes (fato sem fato) 14
2.2 Esquema estrela 2 – Internações hospitalares 16
2.3 Esquema estrela 3 – Produção ambulatorial 17
2.4 Aspectos adicionais de modelagem 19
2.5 Constelação de fatos 21
3. Consultas 23
Consulta 1 – Roll-up 23
Consulta 2 – Drill-down 25
Consulta 3 – Slice and dice 27
Consulta 4 – Pivot 28
Consulta 5 – Drill-across 29
Resumo das consultas 32

1. Descrição do Problema

1.1 Tema geral do trabalho

O tema do trabalho é a **cobertura da atenção básica (Atenção Primária à Saúde – APS) no município de São Carlos (SP)**, analisada a partir de três ângulos complementares: a **oferta** de equipes de saúde, a **demanda** por atendimentos ambulatoriais e as **internações hospitalares evitáveis**. O trabalho se insere na temática da disciplina de apoio à formulação de políticas públicas municipais e utiliza exclusivamente dados reais e oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS) e do IBGE.

A atenção básica é a porta de entrada do SUS: são as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as Unidades de Saúde da Família (USF), com suas equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Primária (eAP), que acompanham a população de um território. Quando esse acompanhamento funciona, problemas como hipertensão, diabetes, asma ou infecções urinárias são controlados no posto de saúde. Quando falha, eles evoluem e acabam em internações hospitalares, que são mais caras para o município e piores para o paciente. Essas internações são chamadas de **Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP)** e têm uma lista oficial definida pela Portaria SAS/MS nº 221/2008. A taxa de ICSAP é um dos indicadores mais usados para avaliar a efetividade da atenção básica.

A **importância** do tema para a gestão municipal está em responder perguntas concretas: quantas equipes de atenção básica o município mantém ao longo do tempo e onde elas estão; que tipo de atendimento ambulatorial a rede realiza; quais internações da população são evitáveis, em que grupos da população e por quais causas; e se variações na oferta de equipes acompanham variações nas internações evitáveis. As respostas apoiam decisões como abrir ou reforçar equipes, priorizar linhas de cuidado (por exemplo, hipertensão e diabetes em idosos) e acompanhar o efeito dessas políticas.

1.2 Fontes de dados

O data warehouse é povoado por cinco fontes, todas públicas e oficiais. As três primeiras são as principais e vêm do DATASUS (Departamento de Informática do SUS), obtidas com a biblioteca PySUS; as duas últimas são fontes auxiliares usadas para enriquecer e integrar as dimensões.

Av. Trabalhador São-carlense, 400 . centro . São Carlos - SP . cep 13566-590 . Brasil . www.icmc.usp.br

Fonte	Conteúdo	Uso no DW
CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, arquivos EP (equipes) e ST (estabelecimentos)	Equipes de saúde cadastradas em cada estabelecimento, com tipo e datas de ativação e desativação; características dos estabelecimentos (tipo de unidade, gestão, município)	Fato de equipes; dimensões de estabelecimento e tipo de equipe
SIH-SUS – Sistema de Informações Hospitalares, arquivo RD (AIH reduzida)	Uma linha por Autorização de Internação Hospitalar: paciente (sexo, idade, município de residência), hospital, diagnóstico, procedimento, dias de permanência, valor	Fato de internações; dimensões de diagnóstico, procedimento, perfil do paciente, localidade e bugiganga
SIA-SUS – Sistema de Informações Ambulatoriais, arquivo PA (produção ambulatorial)	Produção ambulatorial por estabelecimento, procedimento, competência, ocupação do profissional (CBO) e perfil do paciente; quantidades e valores apresentados e aprovados	Fato de produção ambulatorial; dimensões de procedimento, perfil, localidade e CBO
IBGE – API de Localidades	Municípios de SP com código de 7 dígitos, nome, região imediata e região intermediária	Nomes e hierarquia geográfica das dimensões de localidade e estabelecimento
Ministério da Saúde – API de Dados Abertos (CNES)	Nome fantasia, bairro e coordenadas de cada estabelecimento	Atributos descritivos da dimensão de estabelecimento

Recorte. O período analisado vai de janeiro de 2023 a dezembro de 2024 (24 competências mensais). Os arquivos do DATASUS são estaduais; do estado de São Paulo são mantidos apenas os registros ligados a São Carlos: equipes sediadas no município, e internações e atendimentos de pacientes **residentes** em São Carlos ou **atendidos** em São Carlos. Manter os dois critérios permite analisar tanto a população do município (que às vezes é internada em outras cidades) quanto a rede instalada no município (que também atende moradores da região).

1.3 Processos de negócio

Foram modelados três processos de negócio (assuntos de interesse), cada um dando origem a uma tabela de fatos.

Av. Trabalhador São-carlense, 400 . centro . São Carlos - SP . cep 13566-590 . Brasil . www.icmc.usp.br

Processo 1 – Oferta de equipes da atenção básica

Descrição e justificativa. Mede a capacidade instalada da atenção básica: quantas equipes estão ativas, de que tipo e em quais estabelecimentos. É a variável de política pública mais diretamente controlada pelo gestor municipal.

- **Grão:** uma equipe ativa em um estabelecimento em um mês (fotografia mensal, ou *snapshot* periódico).
- **Dimensões:** tempo (mês), estabelecimento, tipo de equipe. O identificador da equipe é guardado como dimensão degenerada.
- **Fatos:** não há medida numérica armazenada; trata-se de uma **tabela de fatos sem fato**. O número de equipes é obtido contando as linhas. Essa contagem é **semiaditiva**: pode ser somada entre estabelecimentos e tipos de equipe, mas não ao longo do tempo (somar as equipes de janeiro e de fevereiro contaria a mesma equipe duas vezes). Ao agregar vários meses, usa-se a média mensal ou o valor do último mês.

Processo 2 – Internações hospitalares

Descrição e justificativa. Registra cada internação paga pelo SUS. Permite identificar as internações sensíveis à atenção primária, que funcionam como sinal de falha da rede básica, e caracterizá-las por causa, faixa etária, sexo e hospital.

- **Grão:** uma internação (uma AIH).
- **Dimensões:** tempo, estabelecimento (hospital), procedimento realizado, diagnóstico principal, perfil do paciente, localidade de residência do paciente e tabela bugiganga (caráter do atendimento, óbito, uso de UTI). O número da AIH é dimensão degenerada.
- **Fatos:** quantidade de internações (sempre 1 por linha, **aditivo**), dias de permanência (**aditivo**) e valor total pago em reais (**aditivo**). A média de permanência é um fato **derivado e não aditivo**, obtido pela soma dos dias dividida pela quantidade de internações.

Processo 3 – Produção ambulatorial

Descrição e justificativa. Mede a demanda atendida nos ambulatórios do SUS: consultas, exames, procedimentos e ações de prevenção. Mostra o volume e o tipo de atendimento que a rede realiza e o perfil de quem é atendido.

- **Grão:** estabelecimento × procedimento × mês × perfil do paciente (sexo e faixa etária) × município de residência × ocupação do profissional. É o menor nível de detalhe disponível no arquivo público do SIA, que já vem parcialmente agregado.

Av. Trabalhador São-carlense, 400 . centro . São Carlos - SP . cep 13566-590 . Brasil . www.icmc.usp.br

- **Dimensões:** tempo, estabelecimento, procedimento, perfil do paciente, localidade de residência, ocupação (CBO).
- **Fatos:** quantidade apresentada, quantidade aprovada, valor apresentado e valor aprovado, todos **aditivos**. A taxa de aprovação é um fato **derivado e não aditivo**: quantidade aprovada dividida pela quantidade apresentada, calculada sempre sobre as somas e nunca somando taxas.

Medidas derivadas entre processos

- **Cobertura estimada de Saúde da Família (%)** = número de equipes eSF × 3.450 pessoas ÷ população do município × 100, limitada a 100%. O parâmetro de 3.450 pessoas por equipe é o usado historicamente pelo Ministério da Saúde. Não aditiva.
- **Taxa de ICSAP por 10 mil habitantes** = internações ICSAP de residentes ÷ população × 10.000. Não aditiva.
- A população usada é a do Censo 2022 do IBGE para São Carlos (254.857 habitantes).

1.4 Dimensões e seus atributos

Todas as dimensões usam uma **chave artificial** (*surrogate key*, prefixo `sk_`) como chave primária, independente dos códigos das fontes. Cada dimensão também tem um membro de chave 0, "Não informado", que recebe os fatos cujo código não é encontrado, para que nenhum registro seja perdido na carga. Nas tabelas abaixo, a coluna "Relação" indica se o atributo participa de uma hierarquia ou é apenas descritivo.

dim_tempo

Mês de competência, isto é, o mês a que o registro se refere no sistema do Ministério da Saúde. Todas as fontes são mensais, então o mês é o menor nível de detalhe comum.

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
sk_tempo	Chave artificial	–	Gerada na carga
ano_mes	Competência no formato AAAAMM	Hierarquia (nível mais baixo)	SIH: ANO_CMPT + MES_CMPT; SIA: PA_MVM; CNES: COMPETEN (integração)
mes	Número do mês (1 a 12)	Descritivo	Derivado de ano_mes

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
nome_mes	Nome abreviado do mês	Descritivo	Derivado de ano_mes
trimestre	Trimestre do ano (ex.: 2024-T1)	Hierarquia	Derivado de ano_mes
semestre	Semestre do ano (ex.: 2024-S1)	Hierarquia	Derivado de ano_mes
ano	Ano	Hierarquia (nível mais alto)	Derivado de ano_mes

dim_estabelecimento

Estabelecimento de saúde (UBS, USF, hospital, clínica, pronto atendimento etc.), identificado pelo código CNES. É compartilhada pelos três processos.

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
sk_ estabelecimento	Chave artificial	–	Gerada na carga
cnes	Código nacional do estabelecimento, 7 dígitos (chave natural)	Hierarquia (nível mais baixo)	CNES, SIH (CNES) e SIA (PA_CODUNI), padronizado com zeros à esquerda
nome	Nome fantasia	Descritivo	API de Dados Abertos (nome_fantasia)
tipo_unidade_cod / tipo_unidade	Tipo do estabelecimento (ex.: 02 – Centro de saúde / Unidade básica)	Hierarquia	CNES-ST (TP_UNID); na falta, API (codigo_ tipo_unidade)
nivel_atencao	Atenção Primária, Especializada, Hospitalar, Urgência ou Outros	Hierarquia	Derivado do tipo de unidade
gestao	Gestão municipal, estadual ou dupla	Descritivo	CNES-ST (TPGESTAO)
bairro	Bairro do estabelecimento	Hierarquia	API de Dados Abertos
latitude / longitude	Coordenadas geográficas	Descritivos	API de Dados Abertos
cod_municipio / municipio	Município do estabelecimento	Hierarquia	CNES-ST (CODUFMUN) + nome do IBGE

Av. Trabalhador São-carlense, 400 . centro . São Carlos - SP . cep 13566-590 . Brasil . www.icmc.usp.br

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
regiao_imediata	Região geográfica imediata do IBGE	Hierarquia	IBGE
uf	Unidade da federação	Hierarquia (nível mais alto)	IBGE / prefixo do código do município

dim_localidade

Município de residência do paciente. Permite separar a população de São Carlos dos pacientes de outras cidades atendidos no município.

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
sk_localidade	Chave artificial	–	Gerada na carga
cod_municipio	Código do município, 6 dígitos	Hierarquia (nível mais baixo)	SIH (MUNIC_RES), SIA (PA_MUNPCN), IBGE (7 dígitos convertidos)
municipio	Nome do município	Descritivo do nível município	IBGE
regiao_imediata	Região imediata do IBGE (ex.: São Carlos)	Hierarquia	IBGE
regiao_ intermediaria	Região intermediária do IBGE (ex.: Araraquara)	Hierarquia	IBGE
uf	Unidade da federação	Hierarquia (nível mais alto)	IBGE / prefixo do código

dim_tipo_equipe

Tipo da equipe de saúde, conforme a classificação do CNES.

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
sk_tipo_equipe	Chave artificial	–	Gerada na carga
tipo_equipe_cod	Código do tipo (ex.: 70)	Hierarquia (nível mais baixo)	CNES-EP (TIPO_EQP)

Av. Trabalhador São-carlense, 400 . centro . São Carlos - SP . cep 13566-590 . Brasil . www.icmc.usp.br

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
tipo_equipe	Descrição (ex.: eSF – Equipe de Saúde da Família)	Descritivo do código	Tabela de tipos de equipe do CNES
categoria_equipe	Saúde da Família, Atenção Primária, Saúde Bucal, Multiprofissional ou Outras	Hierarquia (nível mais alto)	Classificação definida pelo grupo

dim_procedimento

Procedimento da Tabela de Procedimentos do SUS (SIGTAP), usada tanto pelo SIA quanto pelo SIH. O próprio código de 10 dígitos é hierárquico.

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
sk_procedimento	Chave artificial	–	Gerada na carga
cod_procedimento	Código de 10 dígitos	Hierarquia (nível mais baixo)	SIA (PA_PROC_ID), SIH (PROC_REA)
forma_ organizacao_cod	6 primeiros dígitos	Hierarquia	Derivado do código
subgrupo_cod	4 primeiros dígitos	Hierarquia	Derivado do código
grupo_cod / grupo	2 primeiros dígitos e nome do grupo (ex.: 03 – Procedimentos clínicos)	Hierarquia (nível mais alto)	Derivado do código + SIGTAP

dim_diagnostico

Diagnóstico principal da internação segundo a CID-10, com a classificação de condição sensível à atenção primária.

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
sk_diagnostico	Chave artificial	–	Gerada na carga
cid	Código CID-10 com 4 caracteres (ex.: J181)	Hierarquia (nível mais baixo)	SIH (DIAG_PRINC)

Av. Trabalhador São-carlense, 400 . centro . São Carlos - SP . cep 13566-590 . Brasil . www.icmc.usp.br

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
cid_categoria	3 primeiros caracteres (ex.: J18)	Hierarquia	Derivado do código
capitulo_num / capitulo	Capítulo da CID-10 (ex.: X – Aparelho respiratório)	Hierarquia	Tabela da CID-10
grupo_icsap	Um dos 19 grupos de ICSAP ou "Não ICSAP"	Hierarquia	Portaria SAS/MS nº 221/2008
icsap	Sim / Não	Hierarquia (nível mais alto)	Derivado de grupo_ icsap

dim_perfil_paciente

Perfil demográfico do paciente. É uma mini-dimensão com todas as combinações de sexo e faixa etária, compartilhada pelos processos 2 e 3.

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
sk_perfil	Chave artificial	–	Gerada na carga
sexo	M, F ou I (ignorado)	Descritivo (independente da faixa)	SIH (SEXO) e SIA (PA_ SEXO), com integração
sexo_desc	Masculino, Feminino ou Ignorado	Descritivo	Derivado de sexo
faixa_etaria	00-04, 05-09, 10-14, 15-19, 20-39, 40-59, 60-69, 70-79, 80+ ou Ignorada	Hierarquia (nível mais baixo)	SIH (IDADE + COD_ IDADE) e SIA (PA_ IDADE), com integração
ciclo_vida	Criança, Adolescente, Adulto ou Idoso	Hierarquia (nível mais alto)	Derivado da faixa etária

dim_cbo

Ocupação do profissional que realizou o atendimento ambulatorial, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações.

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
sk_cbo	Chave artificial	–	Gerada na carga

Av. Trabalhador São-carlense, 400 . centro . São Carlos - SP . cep 13566-590 . Brasil . www.icmc.usp.br

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
cbo	Código de 6 dígitos (ex.: 225142 – médico da estratégia de Saúde da Família)	Hierarquia (nível mais baixo)	SIA (PA_CBOCOD)
familia_cbo	4 primeiros dígitos	Hierarquia	Derivado do código
categoria_ profissional	Médico, Enfermeiro, Técnico/auxiliar de enfermagem, Cirurgião-dentista, Agente comunitário ou Outros	Hierarquia (nível mais alto)	Classificação definida pelo grupo a partir da família

dim_junk_internacao

Tabela bugiganga (*junk dimension*) que reúne indicadores de baixa cardinalidade da internação. Isolados, cada um viraria uma dimensão com dois a seis valores; juntos, formam uma única dimensão com apenas as combinações que ocorrem nos dados.

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
sk_junk	Chave artificial	–	Gerada na carga
carater_ atendimento	Eletivo, Urgência ou tipos de acidente	Descritivo	SIH (CAR_INT)
obito	Sim / Não	Descritivo	SIH (MORTE)
uti	Sim / Não (houve diárias de UTI)	Descritivo	SIH (UTI_MES_TO > 0)

1.5 Povoamento e integração dos dados

O povoamento segue um processo de extração, transformação e carga. Cada arquivo mensal do estado de São Paulo é lido em lotes, apenas com as colunas necessárias, e só os registros ligados a São Carlos são mantidos. Em seguida, os códigos são padronizados, as dimensões são montadas com chaves artificiais e as tabelas de fatos recebem essas chaves.

A **integração** é necessária sempre que o mesmo dado chega de mais de uma fonte com representações diferentes. Os casos encontrados e a representação escolhida para o data warehouse são:

Av. Trabalhador São-carlense, 400 . centro . São Carlos - SP . cep 13566-590 . Brasil . www.icmc.usp.br

Dado	Fonte A	Fonte B	Representação no DW
Sexo	SIH: 1 = masculino; 3 (ou 2) = feminino; demais = ignorado	SIA: M, F; demais = ignorado	M, F, I
Idade	SIH: valor + unidade (COD_IDADE: dias, meses, anos ou centenas de anos)	SIA: idade em anos	Idade em anos convertida para faixa etária; menores de 1 ano entram em 00-04
Município	DATASUS: código de 6 dígitos	IBGE: código de 7 dígitos (com dígito verificador)	6 dígitos, com o nome vindo do IBGE
Competência	SIH: ano e mês em colunas separadas	SIA e CNES: AAAAMM	ano_mes no formato AAAAMM
Tipo de unidade	CNES-ST: texto com dois dígitos (”02”)	API de Dados Abertos: inteiro (2)	Texto com dois dígitos; o CNES-ST tem prioridade e a API completa o que faltar
Código CNES	SIH, SIA e CNES, às vezes sem zeros à esquerda	API: inteiro	Texto com 7 dígitos
Município do estabeleci-mento	CNES-ST (CODUFMUN)	API de Dados Abertos (codigo_municipio)	CNES-ST com prioridade; API como alternativa

O processo foi executado com os dados reais de janeiro de 2023 a dezembro de 2024 (notebook `dw_aps_sao_carlos.ipynb`, banco DuckDB). A carga resultou em 1.686 linhas em fato_equipe, 39.609 em fato_internacao e 193.723 em fato_producao_ambulatorial, com todas as chaves estrangeiras resolvidas. Para validar a extração, o número de AIHs de residentes foi comparado com o TabNet do DATASUS: em janeiro de 2024 o TabNet mostra 1.287 e o DW 1.285, diferença que corresponde exatamente às AIHs de continuação descartadas de propósito; em abril de 2023 e dezembro de 2024 a diferença é de uma AIH em cerca de 1.400.

1.6 Particularidades do problema

- **Competência versus data do evento.** Os sistemas do SUS organizam os dados pelo mês de apresentação (competência). Uma internação iniciada em dezembro pode ser

apresentada em janeiro. O DW usa a competência em todos os processos, o que mantém os três fatos comparáveis e coincide com a forma como o próprio Ministério da Saúde tabula os dados. No SIA isso significa usar o mês de processamento (`PA_MVM`), e não o mês do atendimento (`PA_CMP`): produção apresentada com atraso cairia em meses fora do período carregado.

- **AIH de longa permanência.** Internações muito longas geram AIHs de continuação (identificação tipo 5) em meses seguintes. Essas linhas são descartadas para que cada internação seja contada uma única vez.
- **Equipes ativas.** O arquivo de equipes do CNES pode listar equipes já desativadas. Só entram no fato as equipes sem data de desativação ou com desativação posterior ao mês. O campo `DT_DESAT` vem como AAAAMM, e o valor 900001 indica equipe nunca desativada.
- **Residência versus local de atendimento.** A pergunta de política pública é sobre a população de São Carlos, por isso as consultas de demanda filtram pelo município de residência. As consultas sobre a rede instalada filtram pelo município do estabelecimento.
- **Limitação do SIA para a atenção básica.** Desde a implantação do e-SUS APS, a produção das UBS é registrada no SISAB e não no SIA. Os dados reais confirmaram isso de forma extrema: as unidades de atenção primária de São Carlos não têm nenhum procedimento no SIA em 2023 e 2024. A produção ambulatorial do SIA representa, portanto, a atenção especializada, diagnóstica e de urgência.
- **Cobertura estimada.** O indicador de cobertura calculado no DW é uma aproximação baseada no parâmetro de pessoas por equipe; a metodologia oficial de cobertura do Ministério mudou ao longo dos anos.

Av. Trabalhador São-carlense, 400 . centro . São Carlos - SP . cep 13566-590 . Brasil . www.icmc.usp.br

2. Esquemas

Legenda dos diagramas: **PK** – chave primária artificial; **FK** – chave estrangeira para uma dimensão; **DD** – dimensão degenerada; **M** – medida. As hierarquias usam o operador de ordenação parcial $\leq$: `A` $\leq$ `B` significa que A é um nível mais detalhado que B, e cada valor de A pertence a um único valor de B.

2.1 Esquema estrela 1 – Oferta de equipes (fato sem fato)

Hierarquias das dimensões

dim_tempo

`ano_mes` $\leq$ `trimestre` $\leq$ `semestre` $\leq$ `ano`

dim_estabelecimento

`cnes` $\leq$ `tipo_unidade` $\leq$ `nivel_atencao`

`cnes` $\leq$ `bairro` $\leq$ `municipio` $\leq$ `regiao_imediata` $\leq$ `uf`

dim_tipo_equipe

`tipo_equipe_cod` $\leq$ `categoria_equipe`

Funções de agregação

Fato	Tipo	Função de agregação
número de equipes (contagem de linhas)	Semiaditivo	CONTAGEM no mesmo mês; entre meses, MÉDIA das contagens mensais ou valor do ÚLTIMO mês

Av. Trabalhador São-carlense, 400 . centro . São Carlos - SP . cep 13566-590 . Brasil . www.icmc.usp.br

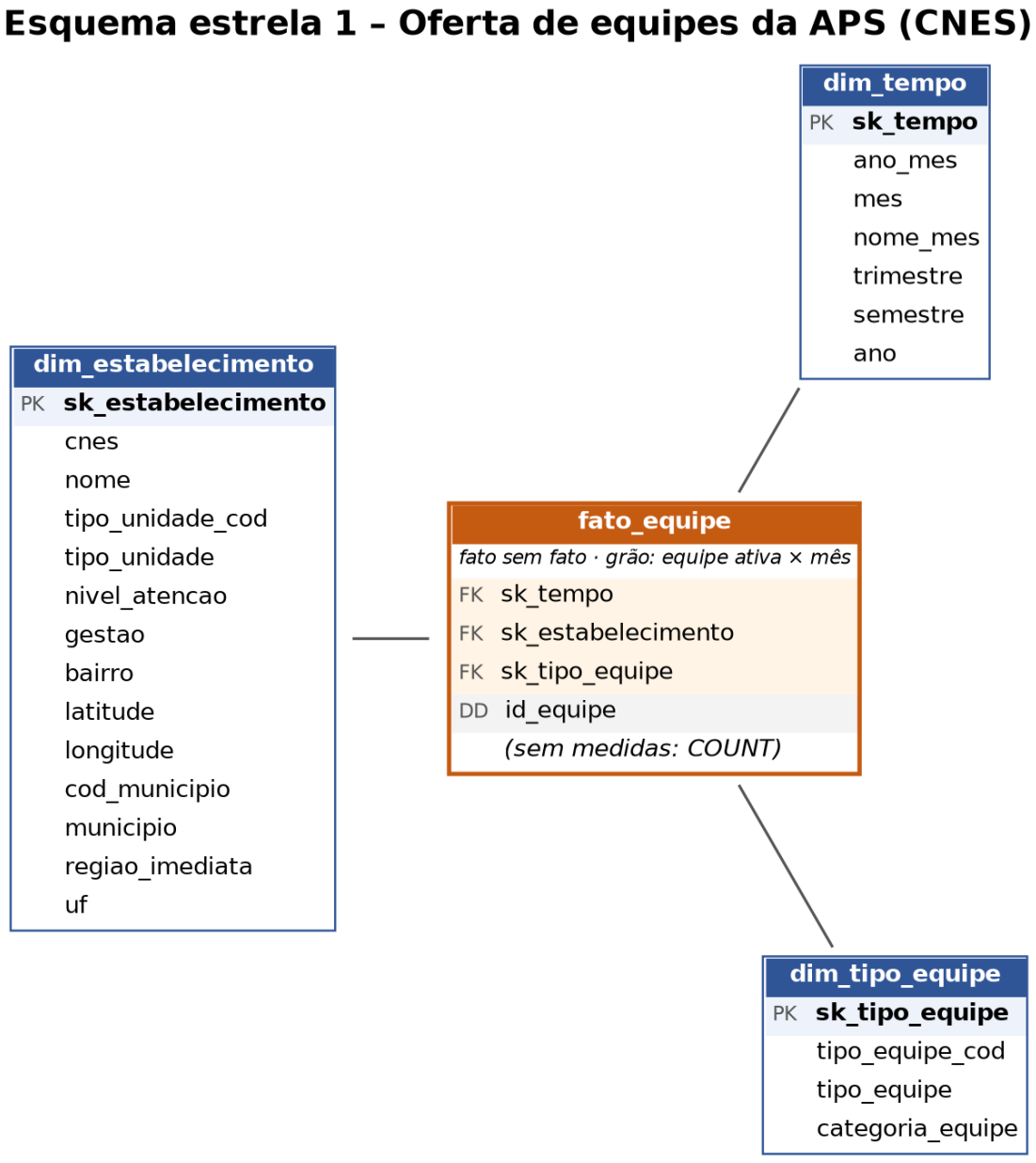


Figura 1 – Esquema estrela da oferta de equipes da atenção básica.

Av. Trabalhador São-carlense, 400 . centro . São Carlos - SP . cep 13566-590 . Brasil . www.icmc.usp.br

2.2 Esquema estrela 2 – Internações hospitalares

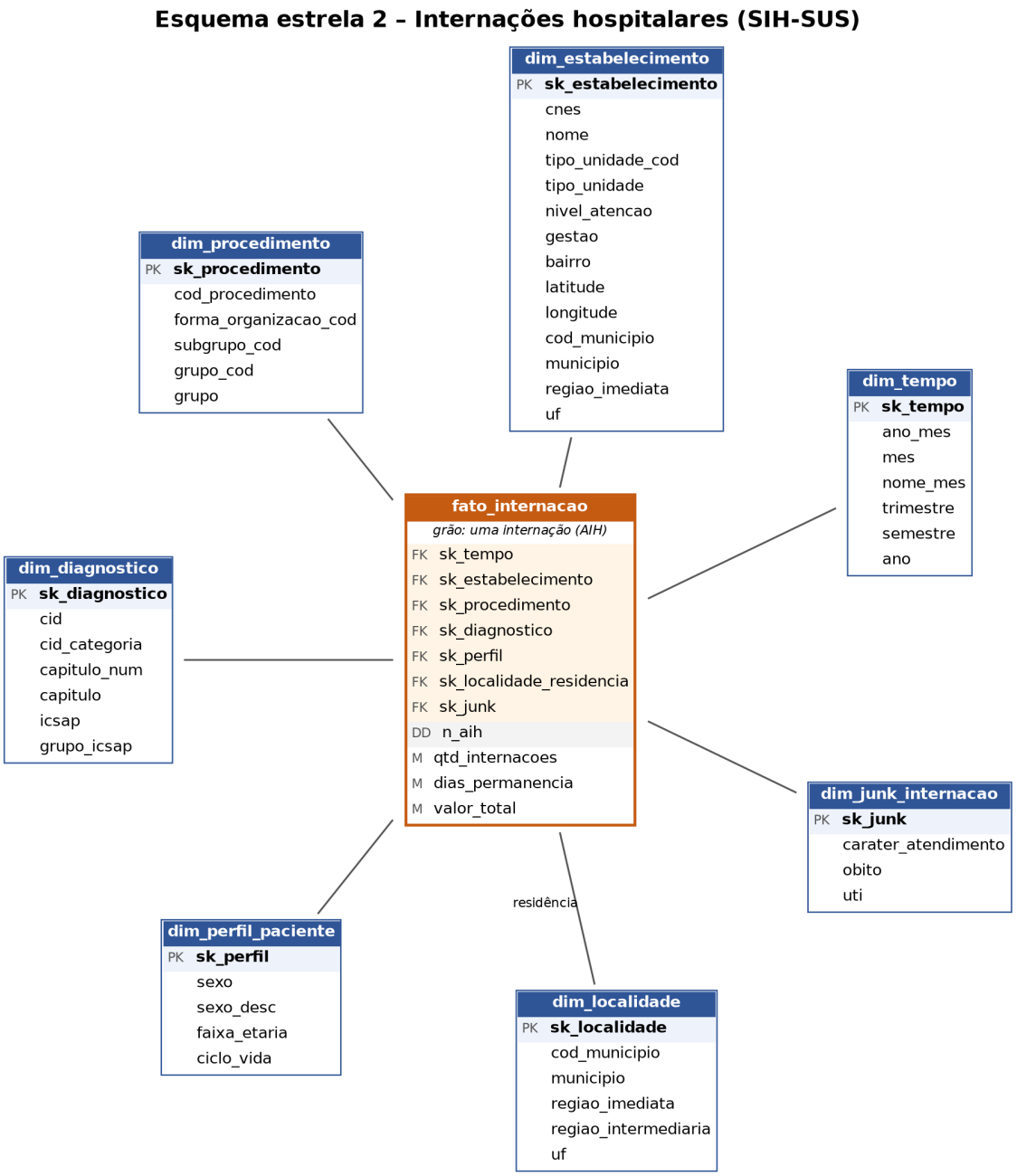


Figura 2 – Esquema estrela das internações hospitalares.

Hierarquias das dimensões

dim_tempo

$$\texttt{ano_mes} \leq \texttt{trimestre} \leq \texttt{semestre} \leq \texttt{ano}$$

dim_estabelecimento

cnes ≤ tipo_unidade ≤ nivel_atencao

cnes ≤ bairro ≤ municipio ≤ regiao_imediata ≤ uf

dim_procedimento

cod_procedimento ≤ forma_organizacao_cod ≤ subgrupo_cod ≤ grupo_cod

dim_diagnostico

cid ≤ cid_categoria ≤ capitulo

cid ≤ grupo_icsap ≤ icsap

dim_perfil_paciente

faixa_etaria ≤ ciclo_vida

(sexo é descritivo, sem hierarquia)

dim_localidade

municipio ≤ regiao_imediata ≤ regiao_intermediaria ≤ uf

dim_junk_internacao

(sem hierarquia; atributos descritivos)

Funções de agregação

Fato	Tipo	Função de agregação
qtd_internacoes	Aditivo	SOMA
dias_permanencia	Aditivo	SOMA
valor_total	Aditivo	SOMA
média de permanência (derivado)	Não aditivo	SOMA(dias_permanencia) ÷ SOMA(qtd_internacoes)
taxa de ICSAP (derivado)	Não aditivo	SOMA(qtd_internacoes ICSAP) ÷ população × 10.000

2.3 Esquema estrela 3 – Produção ambulatorial

Hierarquias das dimensões

dim_tempo

ano_mes ≤ trimestre ≤ semestre ≤ ano

Av. Trabalhador São-carlense, 400 . centro . São Carlos - SP . cep 13566-590 . Brasil . www.icmc.usp.br

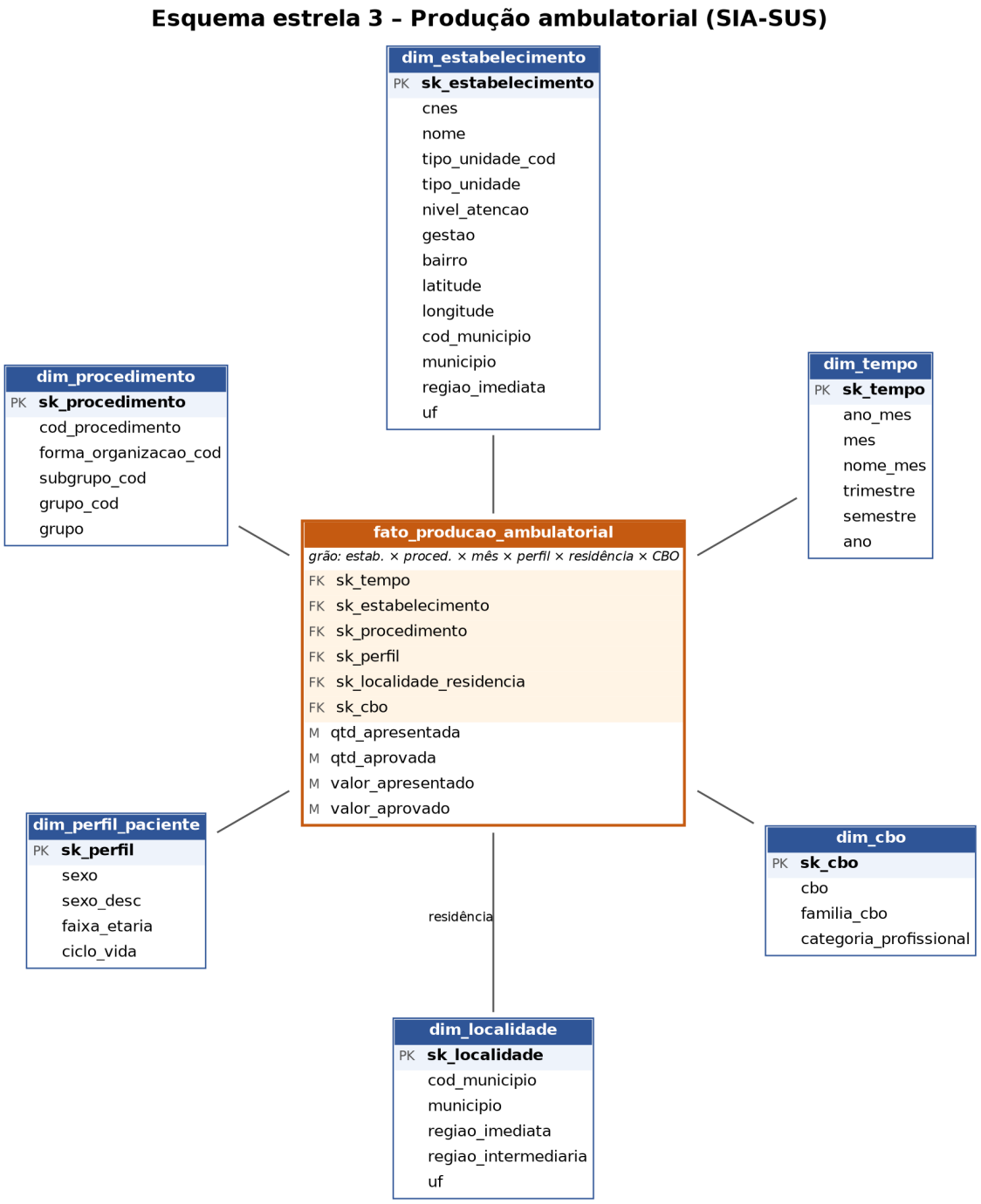


Figura 3 – Esquema estrela da produção ambulatorial.

dim_estabelecimento

`cnes` ≤ `tipo_unidade` ≤ `nivel_atencao`
`cnes` ≤ `bairro` ≤ `municipio` ≤ `regiao_imediata` ≤ `uf`

dim_procedimento

`cod_procedimento` ≤ `forma_organizacao_cod` ≤ `subgrupo_cod` ≤ `grupo_cod`

dim_perfil_paciente

`faixa_etaria` ≤ `ciclo_vida`
(`sexo` é descritivo, sem hierarquia)

dim_localidade

`municipio` ≤ `regiao_imediata` ≤ `regiao_intermediaria` ≤ `uf`

dim_cbo

`cbo` ≤ `familia_cbo` ≤ `categoria_profissional`

Funções de agregação

Fato	Tipo	Função de agregação
qtd_apresentada	Aditivo	SOMA
qtd_aprovada	Aditivo	SOMA
valor_apresentado	Aditivo	SOMA
valor_aprovado	Aditivo	SOMA
taxa de aprovação (derivado)	Não aditivo	SOMA(qtd_aprovada) ÷ SOMA(qtd_apresentada)

2.4 Aspectos adicionais de modelagem

- **Chaves artificiais:** todas as dimensões têm chave primária artificial, o que isola o DW de mudanças nos códigos das fontes, permite o membro "Não informado" (chave 0) e reduz o tamanho das tabelas de fatos.
- **Tabela bugiganga:** `dim_junk_internacao` reúne caráter do atendimento, óbito e uso de UTI.
- **Dimensões degeneradas:** `n_aih` em fato_internacao e `id_equipe` em fato_equipe. São identificadores sem outros atributos, úteis para contar itens distintos e rastrear o registro na fonte.

Av. Trabalhador São-carlense, 400 . centro . São Carlos - SP . cep 13566-590 . Brasil . www.icmc.usp.br

- **Tabela de fatos sem fato:** `fato_equipe` registra apenas a existência de uma equipe ativa em um estabelecimento em um mês; a análise é feita por contagem.
- **Mini-dimensão:** `dim_perfil_paciente` separa os atributos demográficos do paciente, que no SUS não tem identificação pública, em uma dimensão pequena e compartilhada.

Av. Trabalhador São-carlense, 400 . centro . São Carlos - SP . cep 13566-590 . Brasil . www.icmc.usp.br

2.5 Constelação de fatos

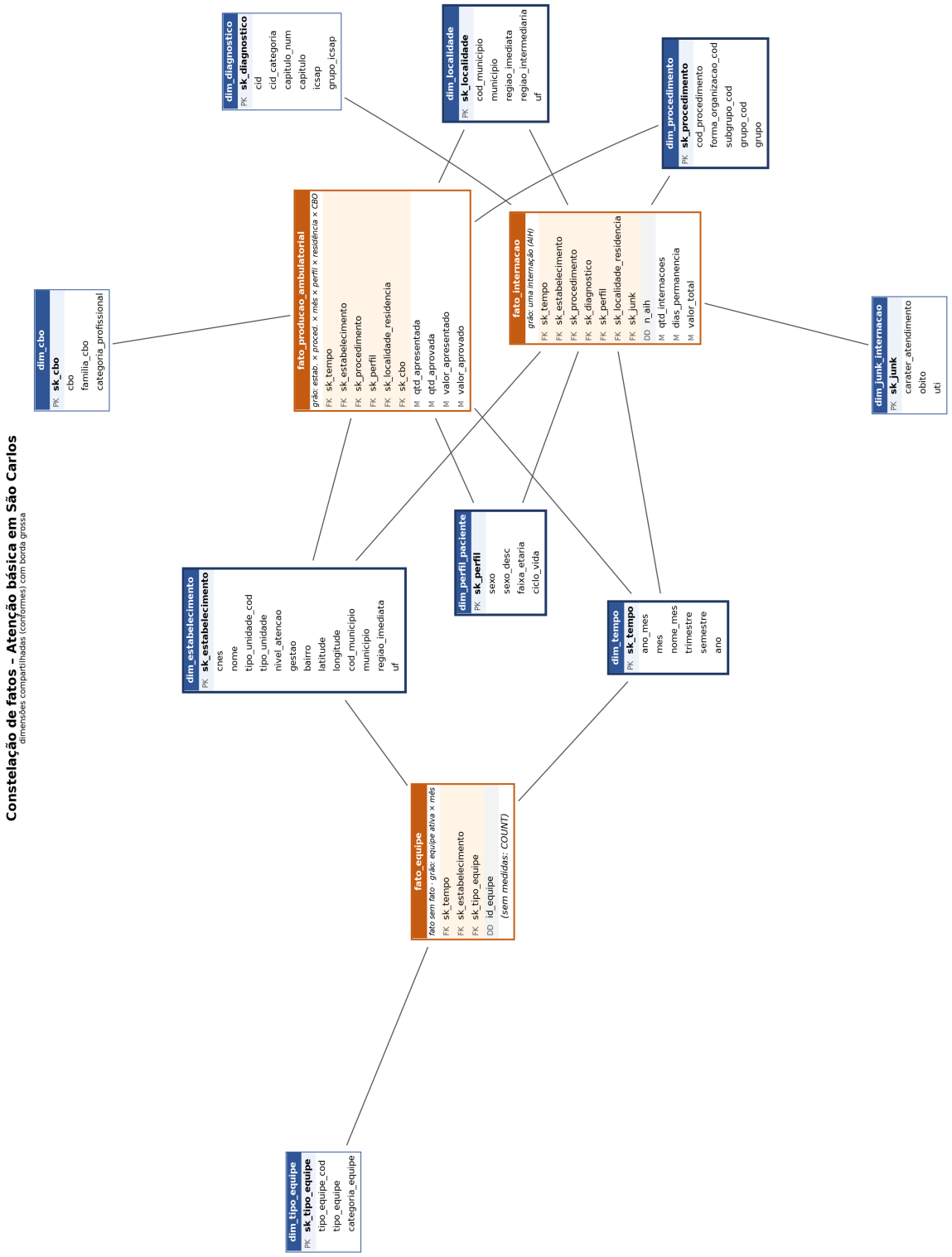


Figura 4 – Constelação de fatos (imagem girada). Dimensões compartilhadas com borda grossa.

Processo de projeto da constelação

A constelação foi obtida em quatro passos:

- **1. Modelagem independente.** Cada processo de negócio foi modelado como uma estrela própria, com seu grão, suas dimensões e seus fatos (Figuras 1 a 3).
- **2. Identificação das dimensões em comum.** Comparando as estrelas, identificaram-se as dimensões que aparecem em mais de uma: tempo, estabelecimento, procedimento, perfil do paciente e localidade.
- **3. Conformação das dimensões.** Cada dimensão comum passou a ter uma única definição, com a mesma chave, os mesmos atributos e os mesmos valores em todas as estrelas. Por exemplo, o tempo usa sempre o mês de competência, o sexo usa sempre M/F/I e o estabelecimento usa sempre o CNES com 7 dígitos, qualquer que seja a fonte. Foi para isso que o grão do tempo foi fixado no mês, o menor nível comum às três fontes.
- **4. Junção.** As três tabelas de fatos passam a apontar para as mesmas tabelas de dimensão, formando a constelação. Isso permite comparar os três processos na mesma análise por meio da operação drill-across (Consulta 5).

A matriz abaixo resume quais dimensões são usadas por cada tabela de fatos.

Dimensão	fato_equipe	fato_internacao	fato_producao_ambulatorial
dim_tempo	✓	✓	✓
dim_estabelecimento	✓	✓	✓
dim_procedimento		✓	✓
dim_perfil_paciente		✓	✓
dim_localidade		✓	✓
dim_tipo_equipe	✓		
dim_diagnostico		✓	
dim_junk_internacao		✓	
dim_cbo			✓

3. Consultas

As consultas abaixo são as principais perguntas que o data warehouse deve responder. Todas usam como filtro o município de São Carlos, pela residência do paciente (demanda) ou pela localização do estabelecimento (oferta).

Todas foram executadas no DW povoado com os dados reais de 2023 e 2024. Para cada uma, o relatório mostra o resultado obtido e uma captura da célula do notebook com o código SQL e a saída. Tabelas longas aparecem com início e fim, separados por "…".

Consulta 1 – Roll-up

Operação OLAP: Roll-up na dimensão tempo (ano_mes → trimestre → ano).

Consulta: Qual o número de internações por condições sensíveis à atenção primária de residentes em São Carlos em cada mês? Em seguida, agregar o resultado por trimestre e por ano.

Elementos do esquema: Tabela de fatos: fato_internacao. Dimensões: tempo (ano_mes, trimestre, ano), diagnóstico (icsap = Sim), localidade (município de residência = São Carlos). Medida: SOMA de qtd_internacoes.

Importância e justificativa: É o indicador central de efetividade da atenção básica. A visão mensal mostra sazonalidade (por exemplo, doenças respiratórias no inverno) e a visão anual mostra a tendência que interessa ao planejamento plurianual do município.

Resultado com os dados reais: Foram 5.255 internações por condições sensíveis à atenção primária de residentes nos dois anos, 16% das 32.799 internações de residentes. No nível mês, o maior valor é dezembro de 2023 (291) e o menor, janeiro de 2024 (167); como o mês é o de processamento da AIH, parte dessa oscilação reflete o ritmo de apresentação dos hospitais. Subindo para trimestre, a série fica entre 572 e 728, e no ano passa de 2.700 (2023) para 2.555 (2024), queda de cerca de 5%.

Av. Trabalhador São-carlense, 400 . centro . São Carlos - SP . cep 13566-590 . Brasil . www.icmc.usp.br

In [13]:
```
BASE_ICSAP = f'''
    FROM fato_internacao f
    JOIN dim_tempo t USING (sk_tempo)
    JOIN dim_diagnostico d USING (sk_diagnostico)
    JOIN dim_localidade l ON l.sk_localidade = f.sk_localidade_residencia
    WHERE d.icsap = 'Sim' AND l.cod_municipio = '{MUN_ALVO}'
'''
print("Nível mês:")
display(q(f"SELECT t.ano_mes, SUM(f.qtd_internacoes) AS internacoes_icsap {BASE_ICSAP}
GROUP BY 1 ORDER BY 1"))

print("Roll-up para trimestre e ano (linhas com NULL são os subtotais):")
q(f'''SELECT t.ano, t.trimestre, SUM(f.qtd_internacoes) AS internacoes_icsap
      {BASE_ICSAP} GROUP BY ROLLUP (t.ano, t.trimestre) ORDER BY t.ano NULLS LAST,
t.trimestre NULLS LAST''')
```

Nível mês:

	ano_mes	internacoes_icsap
0	202301	210
1	202302	172
2	202303	218
3	202304	236
4	202305	261
...	...	...
19	202408	228
20	202409	221
21	202410	241
22	202411	217
23	202412	214

24 rows × 2 columns

Roll-up para trimestre e ano (linhas com NULL são os subtotais):

Out[13]:

	ano	trimestre	internacoes_icsap
0	2023	2023-T1	600
1	2023	2023-T2	728
2	2023	2023-T3	673
3	2023	2023-T4	699
4	2023	None	2700
5	2024	2024-T1	572
6	2024	2024-T2	652
7	2024	2024-T3	659
8	2024	2024-T4	672
9	2024	None	2555
10	<NA>	None	5255

Figura 5 – Consulta 1 no notebook: ICSAP por mês e roll-up para trimestre e ano (linhas com NULL são os subtotais).

Consulta 2 – Drill-down

Operação OLAP: Drill-down na dimensão procedimento (grupo → subgrupo → procedimento).

Consulta: Qual a quantidade aprovada de procedimentos ambulatoriais realizados em estabelecimentos de São Carlos por grupo de procedimento? Para o grupo com maior volume, detalhar por subgrupo e, para o subgrupo principal, por procedimento.

Elementos do esquema: Tabela de fatos: fato_producao_ambulatorial. Dimensões: procedimento (grupo_cod, subgrupo_cod, cod_procedimento), estabelecimento (município = São Carlos). Medidas: SOMA de qtd_aprovada e de valor_aprovado.

Importância e justificativa: Mostra que tipo de atendimento a rede ambulatorial mais realiza e permite descer até os procedimentos específicos que concentram o volume e o gasto, apoiando o dimensionamento de oferta e de contratos.

Resultado com os dados reais: O grupo 02 (procedimentos com finalidade diagnóstica) lidera em quantidade, com 1,77 milhão de procedimentos aprovados; o grupo 03 (procedimentos clínicos) vem em segundo em quantidade, mas tem o maior valor aprovado, cerca de R$ 31,3 milhões. Descendo no grupo 02, o subgrupo 0202 (diagnóstico em laboratório clínico) concentra 1,39 milhão, e no nível de procedimento os maiores volumes são o hemograma completo (0202020380, 126.646) e a dosagem de creatinina (0202010317, 101.989).

Av. Trabalhador São-carlense, 400 . centro . São Carlos - SP . cep 13566-590 . Brasil . www.icmc.usp.br

In [14]:
```
BASE_PROD = f'''
    FROM fato_producao_ambulatorial f
    JOIN dim_procedimento p USING (sk_procedimento)
    JOIN dim_estabelecimento e USING (sk_estabelecimento)
    WHERE e.cod_municipio = '{MUN_ALVO}'
'''
g = q(f"SELECT p.grupo_cod, p.grupo, SUM(f.qtd_aprovada) AS qtd_aprovada,
SUM(f.valor_aprovado) AS valor_aprovado "
      f"{BASE_PROD} GROUP BY 1, 2 ORDER BY 3 DESC")
display(g)
if len(g):
    grupo = g.iloc[0]["grupo_cod"]
    print(f"Drill-down no grupo {grupo} → subgrupo:")
    sg = q(f"SELECT p.subgrupo_cod, SUM(f.qtd_aprovada) AS qtd_aprovada {BASE_PROD} AND
p.grupo_cod = '{grupo}' "
           f"GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC")
    display(sg)
    if len(sg):
        sub = sg.iloc[0]["subgrupo_cod"]
        print(f"Drill-down no subgrupo {sub} → procedimento (top 10):")
        display(q(f"SELECT p.cod_procedimento, SUM(f.qtd_aprovada) AS qtd_aprovada
{BASE_PROD} "
                  f"AND p.subgrupo_cod = '{sub}' GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 10"))
```

	grupo_cod	grupo	qtd_aprovada	valor_aprovado
0	02	Procedimentos com finalidade diagnóstica	1767091	18,015,200.70
1	03	Procedimentos clínicos	1055094	31,280,793.32
2	01	Ações de promoção e prevenção em saúde	73886	4,375.44
3	08	Ações complementares da atenção à saúde	36676	181,546.20
4	04	Procedimentos cirúrgicos	29067	3,550,130.60
5	07	Órteses, próteses e materiais especiais	699	599,707.09

Drill-down no grupo 02 → subgrupo:

	subgrupo_cod	qtd_aprovada
0	0202	1390094
1	0211	148935
2	0204	84022
3	0205	57799
4	0212	24208
...	...	...
9	0207	6647
10	0201	5823
11	0208	1887
12	0213	50
13	0210	26

14 rows × 2 columns

Drill-down no subgrupo 0202 → procedimento (top 10):

	cod_procedimento	qtd_aprovada
0	0202020380	126646
1	0202010317	101989
2	0202050017	71391
3	0202010473	67970
4	0202010694	67140
5	0202010600	64799
6	0202010295	59248
7	0202010635	58311
8	0202010678	55490
9	0202010651	52496

Figura 6 – Consulta 2 no notebook: produção aprovada por grupo e drill-down até o procedimento.

Av. Trabalhador São-carlense, 400 . centro . São Carlos - SP . cep 13566-590 . Brasil . www.icmc.usp.br

Consulta 3 – Slice and dice

In [15]:
```
q(f'''
SELECT d.grupo_icsap, pp.sexo_desc, SUM(f.qtd_internacoes) AS internacoes,
ROUND(AVG(f.dias_permanencia), 1) AS media_dias
FROM fato_internacao f
JOIN dim_tempo t USING (sk_tempo)
JOIN dim_diagnostico d USING (sk_diagnostico)
JOIN dim_perfil_paciente pp USING (sk_perfil)
JOIN dim_localidade l ON l.sk_localidade = f.sk_localidade_residencia
WHERE t.ano = {ANOS[-1]} AND pp.ciclo_vida = 'Idoso' AND d.icsap = 'Sim' AND
l.cod_municipio = '{MUN_ALVO}'
GROUP BY 1, 2 ORDER BY 3 DESC
''')
```

Out[15]:

	grupo_icsap	sexo_desc	internacoes	media_dias
0	12 Doenças cerebrovasculares	Masculino	170	5.30
1	12 Doenças cerebrovasculares	Feminino	154	4.90
2	11 Insuficiência cardíaca	Feminino	128	7.00
3	11 Insuficiência cardíaca	Masculino	114	9.20
4	10 Angina	Masculino	89	3.00
...	...	...	...	...
28	04 Deficiências nutricionais	Masculino	3	5.00
29	07 Asma	Masculino	2	8.00
30	17 Doença inflamatória de órgãos pélvicos femi...	Feminino	2	4.00
31	03 Anemia	Feminino	1	1.00
32	05 Infecções de ouvido, nariz e garganta	Feminino	1	1.00

33 rows × 4 columns

Figura 7 – Consulta 3 no notebook: ICSAP de idosos residentes em 2024 por grupo de causa e sexo.

Operação OLAP: Slice na dimensão tempo (ano = 2024) e dice nas dimensões perfil do paciente (ciclo de vida = Idoso) e diagnóstico (icsap = Sim).

Consulta: Quantas internações por condições sensíveis à atenção primária de idosos residentes em São Carlos ocorreram em 2024, e qual a média de dias de permanência, por grupo de causa e por sexo?

Elementos do esquema: Tabela de fatos: fato_internacao. Dimensões: tempo (ano), perfil do paciente (ciclo_vida, sexo), diagnóstico (icsap, grupo_icsap), localidade. Medidas: SOMA de qtd_internacoes; média de permanência (derivada).

Importância e justificativa: Os idosos concentram as condições crônicas acompanhadas pela atenção básica, como doenças cerebrovasculares e insuficiência cardíaca. Identificar as causas que mais internam esse grupo orienta ações como grupos de hipertensos e diabéticos e visitas domiciliares.

Resultado com os dados reais: Foram 1.358 internações evitáveis de idosos residentes em 2024. As doenças cerebrovasculares lideram (170 homens e 154 mulheres), seguidas da insuficiência cardíaca (128 mulheres e 114 homens) e da angina (89 homens). Entre as causas mais frequentes, as doenças pulmonares e a insuficiência cardíaca têm as maiores médias de permanência.

Consulta 4 – Pivot

```
In [16]: base = q(f"SELECT d.grupo_icsap, pp.ciclo_vida, SUM(f.qtd_internacoes) AS n "
                 f"FROM fato_internacao f JOIN dim_diagnostico d USING (sk_diagnostico) "
                 f"JOIN dim_perfil_paciente pp USING (sk_perfil) "
                 f"JOIN dim_localidade l ON l.sk_localidade = f.sk_localidade_residencia "
                 f"WHERE d.icsap = 'Sim' AND l.cod_municipio = '{MUN_ALVO}' GROUP BY 1, 2")
         if len(base):
             visao = base.pivot_table(index="grupo_icsap", columns="ciclo_vida", values="n", aggfunc="sum", fill_value=0)
             print("Linhas = causa, colunas = ciclo de vida"); display(visao)
             print("Pivot (eixos rotacionados): linhas = ciclo de vida, colunas = causa")
             with pd.option_context("display.max_columns", 8):   # 19 causas: mostra as primeiras e as últimas
                 display(visao.T)
```

Linhas = causa, colunas = ciclo de vida

grupo_icsap \ ciclo_vida	Adolescente	Adulto	Criança	Idoso
01 Preveníveis por imunização e condições sensíveis	5	58	12	21
02 Gastroenterites infecciosas	3	33	79	51
03 Anemia	0	3	2	3
04 Deficiências nutricionais	1	4	5	13
05 Infecções de ouvido, nariz e garganta	5	10	41	2
...	...	...	...	...
15 Infecção no rim e trato urinário	15	204	29	299
16 Infecção da pele e tecido subcutâneo	10	189	40	137
17 Doença inflamatória de órgãos pélvicos femininos	10	43	0	3
18 Úlcera gastrointestinal	2	130	6	245
19 Doenças relacionadas ao pré-natal e parto	4	31	43	0

19 rows × 4 columns

Pivot (eixos rotacionados): linhas = ciclo de vida, colunas = causa

ciclo_vida \ grupo_icsap	01 Preveníveis por imunização e condições sensíveis	02 Gastroenterites infecciosas	03 Anemia	04 Deficiências nutricionais	...	16 Infecção da pele e tecido subcutâneo	17 Doença inflamatória de órgãos pélvicos femininos	18 Úlcera gastrointestinal	19 Doenças relacionadas ao pré-natal e parto
Adolescente	5	3	0	1	...	10	10	2	4
Adulto	58	33	3	4	...	189	43	130	31
Criança	12	79	2	5	...	40	0	6	43
Idoso	21	51	3	13	...	137	3	245	0

4 rows × 19 columns

Figura 8 – Consulta 4 no notebook: ICSAP por causa × ciclo de vida e a mesma tabela rotacionada.

Operação OLAP: Pivot (rotação) entre as dimensões diagnóstico e perfil do paciente.

Consulta: Qual o número de internações por condições sensíveis à atenção primária de residentes em São Carlos por grupo de causa (linhas) e ciclo de vida (colunas)? Em seguida,

rotacionar a visão, com ciclo de vida nas linhas e grupo de causa nas colunas.

Elementos do esquema: Tabela de fatos: fato_internacao. Dimensões: diagnóstico (grupo_icsap), perfil do paciente (ciclo_vida), localidade. Medida: SOMA de qtd_internacoes.

Importância e justificativa: As duas orientações respondem perguntas diferentes do gestor: "quais causas pesam em cada fase da vida?" (útil para programas por público, como saúde da criança e do idoso) e "qual fase da vida mais sofre com cada causa?" (útil para linhas de cuidado por doença).

Resultado com os dados reais: Na primeira orientação, cada causa mostra em que fase da vida pesa: as doenças circulatórias são quase exclusivas de adultos e idosos (621 idosos com doença cerebrovascular nos dois anos). Na orientação rotacionada, cada fase da vida mostra suas causas: nas crianças predominam as doenças pulmonares (329) e a asma (159); nos adultos, as doenças cerebrovasculares (229), a infecção do rim e trato urinário (204) e a de pele e subcutâneo (189).

Consulta 5 – Drill-across

Operação OLAP: Drill-across entre fato_equipe, fato_producao_ambulatorial e fato_internacao, pela dimensão conforme tempo (e pelo município).

Consulta: Em cada mês, quantas equipes de Saúde da Família estavam ativas em São Carlos, qual a cobertura estimada correspondente, quantos procedimentos ambulatoriais foram aprovados nos estabelecimentos de atenção primária do município e quantas internações por condições sensíveis à atenção primária de residentes ocorreram (em número absoluto e por 10 mil habitantes)?

Elementos do esquema: Cada tabela de fatos é agregada separadamente por ano_mes e os três resultados são combinados pelo mês. fato_equipe: CONTAGEM de equipes com categoria_equipe = Saúde da Família. fato_producao_ambulatorial: SOMA de qtd_aprovada com nivel_atencao = Atenção Primária. fato_internacao: SOMA de qtd_internacoes com icsap = Sim e residência = São Carlos. Medidas derivadas: cobertura estimada e taxa de ICSAP.

Importância e justificativa: Responde a pergunta central do trabalho: variações na oferta de atenção básica acompanham variações nas internações evitáveis? Só é possível porque as três estrelas compartilham dimensões conformes, e o resultado subsidia a decisão de expandir ou manter equipes.

Resultado com os dados reais: O drill-across funcionou como projetado e expôs dois fatos sobre as fontes. Primeiro, São Carlos manteve 23 equipes de Saúde da Família ativas em

Av. Trabalhador São-carlense, 400 . centro . São Carlos - SP . cep 13566-590 . Brasil . www.icmc.usp.br

In [17]:
```
drill = q(f'''
WITH oferta AS (
    SELECT f.sk_tempo, COUNT(*) AS equipes_sf
    FROM fato_equipe f JOIN dim_tipo_equipe te USING (sk_tipo_equipe)
    JOIN dim_estabelecimento e USING (sk_estabelecimento)
    WHERE te.categoria_equipe = 'Saúde da Família' AND e.cod_municipio = '{MUN_ALVO}'
    GROUP BY 1),
producao AS (
    SELECT f.sk_tempo, SUM(f.qtd_aprovada) AS producao_aps
    FROM fato_producao_ambulatorial f JOIN dim_estabelecimento e USING
(sk_estabelecimento)
    WHERE e.nivel_atencao = 'Atenção Primária' AND e.cod_municipio = '{MUN_ALVO}'
    GROUP BY 1),
icsap AS (
    SELECT f.sk_tempo, SUM(f.qtd_internacoes) AS internacoes_icsap
    FROM fato_internacao f JOIN dim_diagnostico d USING (sk_diagnostico)
    JOIN dim_localidade l ON l.sk_localidade = f.sk_localidade_residencia
    WHERE d.icsap = 'Sim' AND l.cod_municipio = '{MUN_ALVO}'
    GROUP BY 1)
SELECT t.ano_mes,
       COALESCE(o.equipes_sf, 0) AS equipes_sf,
       ROUND(LEAST(100, 100.0 * COALESCE(o.equipes_sf, 0) * 3450 / {POP_MUN}), 1) AS
cobertura_estimada_pct,
       COALESCE(p.producao_aps, 0) AS producao_aps,
       COALESCE(i.internacoes_icsap, 0) AS internacoes_icsap,
       ROUND(10000.0 * COALESCE(i.internacoes_icsap, 0) / {POP_MUN}, 2) AS
taxa_icsap_10mil
FROM dim_tempo t
LEFT JOIN oferta o USING (sk_tempo)
LEFT JOIN producao p USING (sk_tempo)
LEFT JOIN icsap i USING (sk_tempo)
WHERE t.sk_tempo > 0 AND t.ano_mes IN ({", ".join(str(a * 100 + m) for a, m in
COMPETENCIAS)})
ORDER BY 1
''')
drill
```

Out[17]:

	ano_mes	equipes_sf	cobertura_estimada_pct	producao_aps	internacoes_icsap	taxa_icsap_10mil
0	202301	23	31.10	0	210	8.24
1	202302	23	31.10	0	172	6.75
2	202303	23	31.10	0	218	8.55
3	202304	23	31.10	0	236	9.26
4	202305	23	31.10	0	261	10.24
...	...	...	...	...	...	...
19	202408	23	31.10	0	228	8.95
20	202409	23	31.10	0	221	8.67
21	202410	23	31.10	0	241	9.46
22	202411	23	31.10	0	217	8.51
23	202412	23	31.10	0	214	8.40

24 rows × 6 columns

Figura 9 – Consulta 5 no notebook: as três tabelas de fatos agregadas por mês e combinadas por ano_mes.

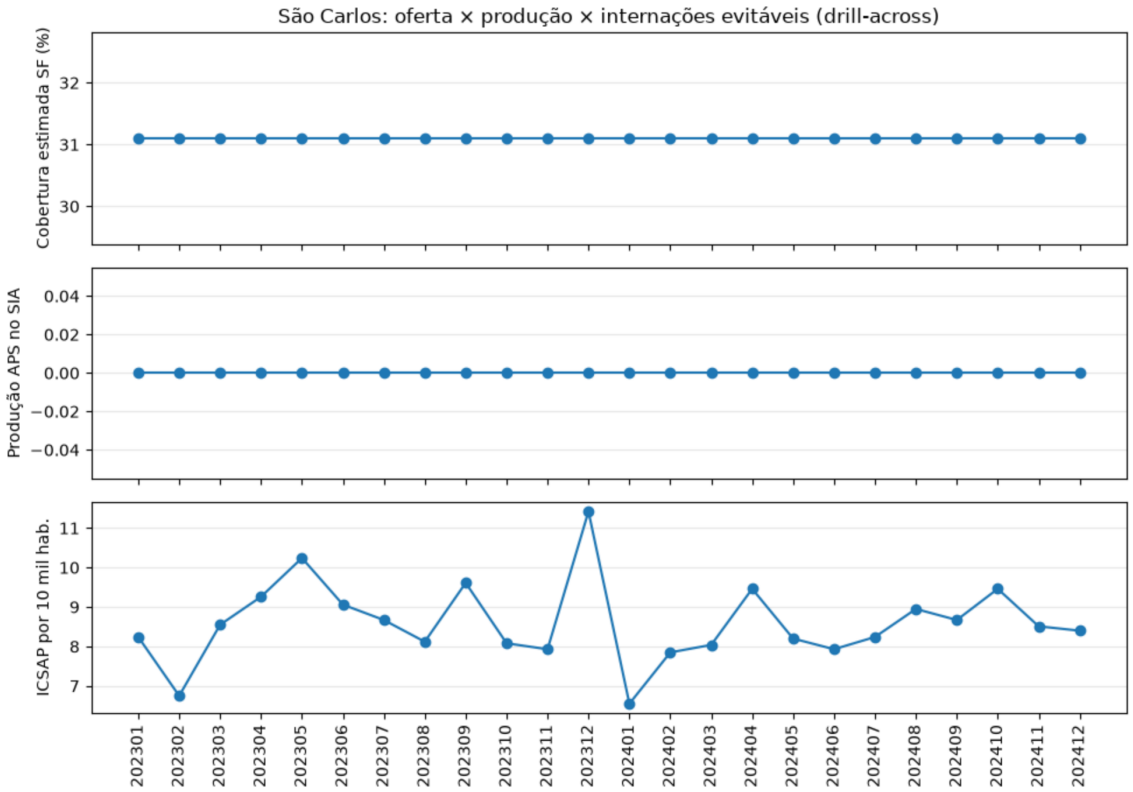


Figura 10 – Consulta 5: resultado mês a mês, um painel por tabela de fatos com o mesmo eixo de tempo.

todos os 24 meses, o que dá cobertura estimada constante de 31,1%. Segundo, a produção APS no SIA é zero em todos os meses, porque a produção das UBS vai para o SISAB (Seção 1.6). A taxa de ICSAP variou entre 6,55 e 11,42 por 10 mil habitantes, terminando 2024 em 8,40. Com a oferta constante no período, ainda não é possível relacionar variações de cobertura e de internações evitáveis: isso exige uma série mais longa e a inclusão do SISAB como fonte.

Resumo das consultas

Consulta	Operação	Tabela(s) de fatos
1	Roll-up	fato_internacao
2	Drill-down	fato_producao_ambulatorial
3	Slice and dice	fato_internacao
4	Pivot	fato_internacao
5	Drill-across	fato_equipe, fato_producao_ambulatorial, fato_internacao

Av. Trabalhador São-carlense, 400 . centro . São Carlos - SP . cep 13566-590 . Brasil . www.icmc.usp.br